CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

Evaluación integral del CAIMI

Análisis de valor público y definición del modelo operativo del Centro de Atención Integral Materno Infantil

Carlos Alberto Sandoval Zambrano

Economista

Neiva, 27 de octubre de 2026

Actualización final con certificación biomédica del 23 de octubre de 2026

Pacientes por periodo	Actividades	Inventario biomédico	Glosas
97.583	**730.301**	**194**	**812**
Suma no desduplicada	Registradas	Registros documentales	Registros

Resumen ejecutivo

Evidencia actualizada y límites para la toma de decisiones

Pacientes por periodo	Actividades registradas	Costo CAIMI 2025	Inventario biomédico
97.583	**730.301**	**$9,83 mil MM**	**194**
Suma reportada; no únicos	Base de producción	COP · costeo por absorción	Registros documentales

Valor sanitario

La alternativa elegida debe conservar acceso, continuidad, atención materno-infantil, urgencias y apoyo diagnóstico.

Lectura financiera

En enero–junio de 2026, la facturación menos el costo reportado es –$520,09 millones. No equivale a utilidad neta ni caja.

Evidencia biomédica

La certificación aporta 14 reportes: 12 vínculos por identificador y 2 asociaciones descriptivas. El registro 8631 sigue sin reporte individual.

La recomendación estratégica de tercerización permanece condicionada. La comparación uniforme de ocho criterios sitúa a continuidad en 3,89 y tercerización en 3,86.

Fuentes: anexos de demanda/producción; 31_Conciliacion_Costos; certificación biomédica, 23-10-2026; matriz de ocho criterios.

Decisión estratégica recomendada

Tercerización condicionada: recomendación previa sujeta a evidencia y salvaguardas

Orientación de gestión

Estructurar una alternativa por resultados, con control público de datos, activos, calidad y continuidad. La tercerización exige factibilidad, reglas de pago y reversibilidad verificables.

Comparación uniforme	Puntaje / 5
Continuidad optimizada	3,8875
Tercerización condicionada	3,8625
Cierre / reconversión	2,5000

- Continuidad presenta una ventaja aritmética mínima de 0,025 puntos; esta matriz no prueba superioridad de tercerización.
- Definir el modelo económico tras conciliar facturación, costos, recaudo, glosas monetarias y obligaciones de inversión.
- Conservar acceso, calidad asistencial, supervisión pública y capacidad de retorno ante incumplimientos.

Fuente: ocho calificaciones originales; promedio con peso técnico uniforme de 12,5% por criterio. Recomendación estratégica condicionada.

Alcance y cumplimiento contractual

Trazabilidad documental del contrato 0481 de 2026

Bloque	Resultado documentado
Diagnóstico integral	Asistencial, técnico-científico, operativo, financiero y contractual
Capacidad y producción	Demanda por periodo, actividades, servicios y centros de costo
Costos y finanzas	Costeo CAIMI, estados E.S.E., glosas y brechas de conciliación
Valor público y escenarios	Acceso, continuidad, equidad, tres escenarios y sensibilidad
Evidencia biomédica	Inventario de 194 registros y conciliación de 15 inicialmente no ubicados
Entregables	Informe, presentación, anexos, matriz de trazabilidad y aplicativo actualizado

La incorporación de la certificación completa el soporte documental recibido para esta actualización. La aceptación del supervisor, la liquidación y el pago son actuaciones diferentes.

Fuente: Contrato 0481-2026, cláusulas de obligaciones, supervisión y liquidación; certificación del 23-10-2026.

Metodología

Triangulación documental, cuantitativa, financiera y multicriterio

01 Fuentes

Versiones y trazabilidad

02 Depuración

Unidades y denominadores

03 Indicadores

Demanda, producción y costos

04 Diagnóstico

Lectura sanitaria y operativa

05 Escenarios

Ocho criterios y sensibilidad

06 Seguimiento

Ruta, responsables y evidencia

Reglas: conservar cortes parciales; separar usuarios de registros; no inferir rentabilidad ni disponibilidad simultánea. Los pesos de 12,5% son un supuesto técnico de comparación.

Fuentes: bases suministradas por la E.S.E., anexos parametrizados y conciliación documental de la certificación biomédica.

Calidad de información y gobierno de datos

Evidencia útil para comparar alternativas; brechas concretas para implementar

Dimensión	Hallazgo	Control necesario
Denominadores	97.583 reportados por periodo ≠ 68.318 usuarios RIPS	Declarar universo y unidad
Finanzas	Costos y facturación disponibles; recaudo/glosa monetaria incompletos	Conciliación mensual por centro
Inventario	194 filas; serie 503352 repetida en ítems 85 y 88	Verificar identidad, sin borrar filas
Certificación	12 vínculos por clave, 2 descriptivos y 1 sin reporte	Corroborar asociaciones y registro 8631
Oportunidad	Fuentes de fechas diferentes; 2023 y 2026 parciales	Mantener fecha y corte por fuente

Decisión que puede prepararse

Comparar alternativas, priorizar riesgos y exigir controles y condiciones de implementación.

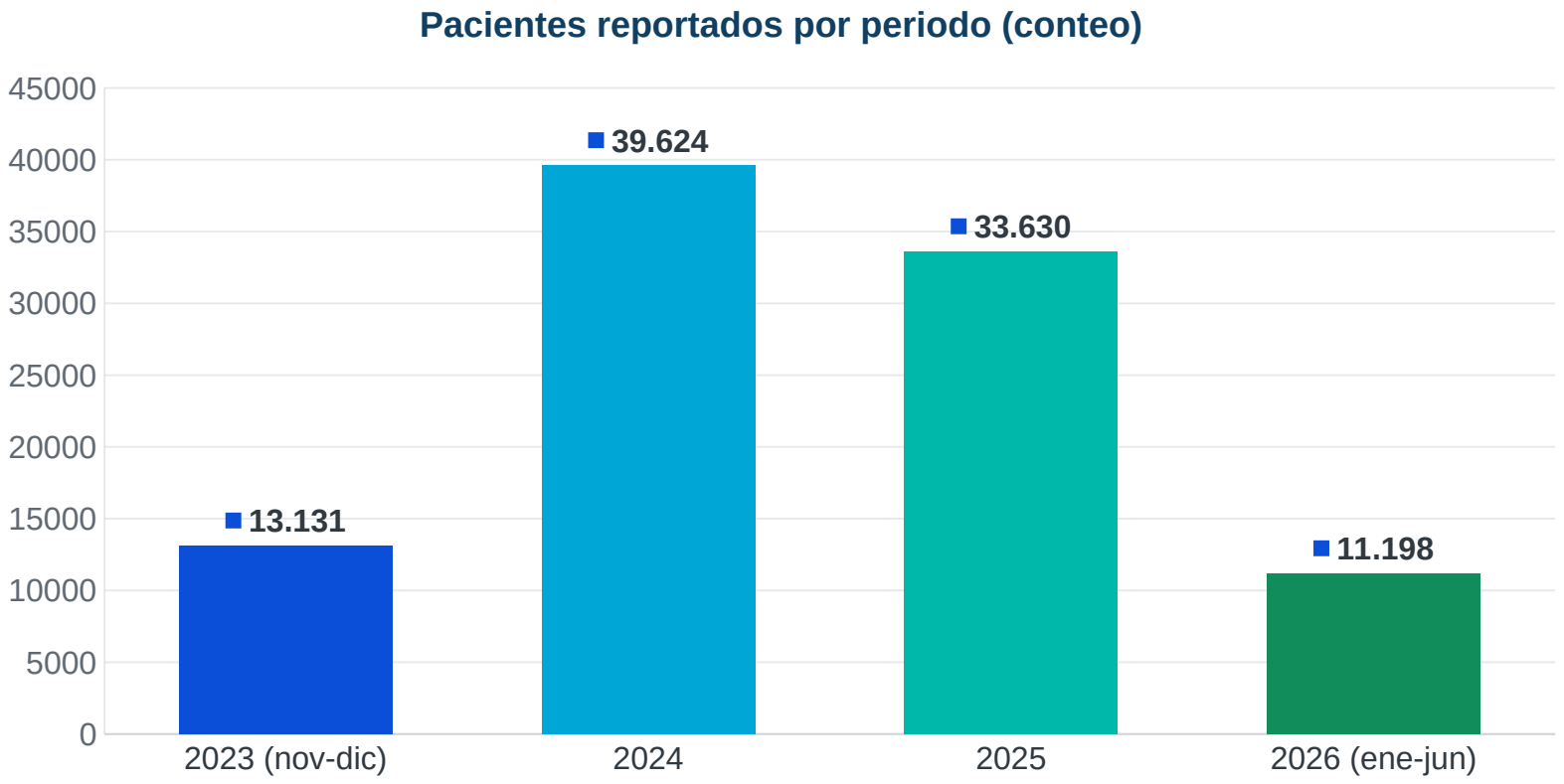
Decisión que requiere conciliación

Cuantificar rentabilidad específica, pagos del operador, inversión y disponibilidad tecnológica.

Fuentes: RIPS del aplicativo; conciliación de costos; inventario y certificación biomédica.

Demanda atendida

97.583 pacientes reportados en cuatro periodos; suma no desduplicada



Lectura ejecutiva

2024 registra el mayor volumen de los periodos presentados. 2023 cubre noviembre–diciembre y 2026 enero–junio; sus totales no son años completos.

Universo diferente

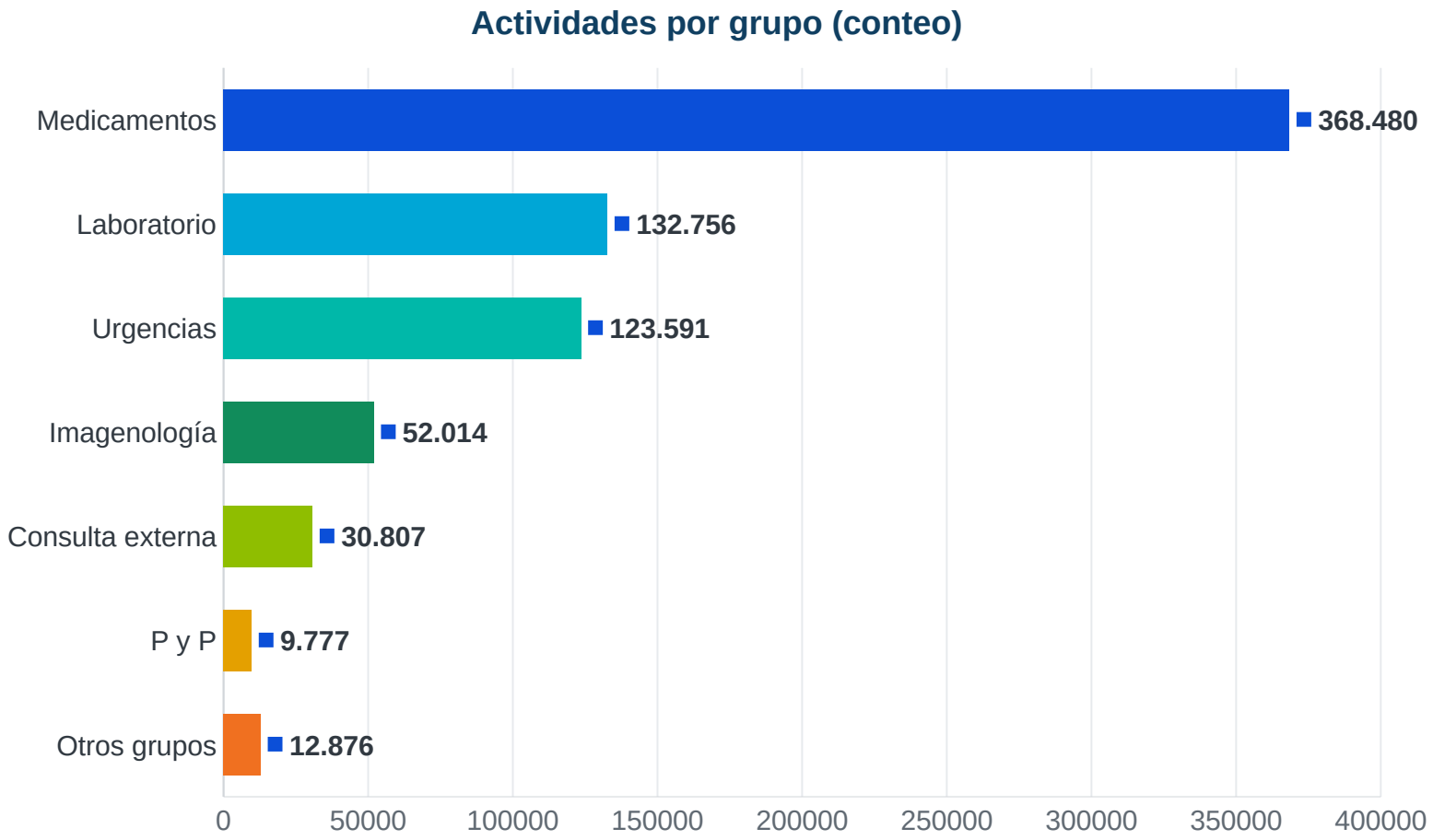
68.318 usuarios distintos del conjunto RIPS. Universo diferente de los 97.583 reportados por periodo.

Los periodos pueden repetir personas. Evitar interpretar 97.583 como usuarios únicos longitudinales o comparar el semestre 2026 como una vigencia cerrada.

Fuente: anexos de pacientes por periodo (2023 nov–dic; 2024; 2025; 2026 ene–jun) y conjunto RIPS del aplicativo.

Producción de servicios

730.301 actividades registradas en la base de producción



Grupo	% del total
Medicamentos	50,5%
Laboratorio	18,2%
Urgencias	16,9%
Imagenología	7,1%
Consulta externa	4,2%
P y P	1,3%
Otros grupos	1,8%

Clave de gestión

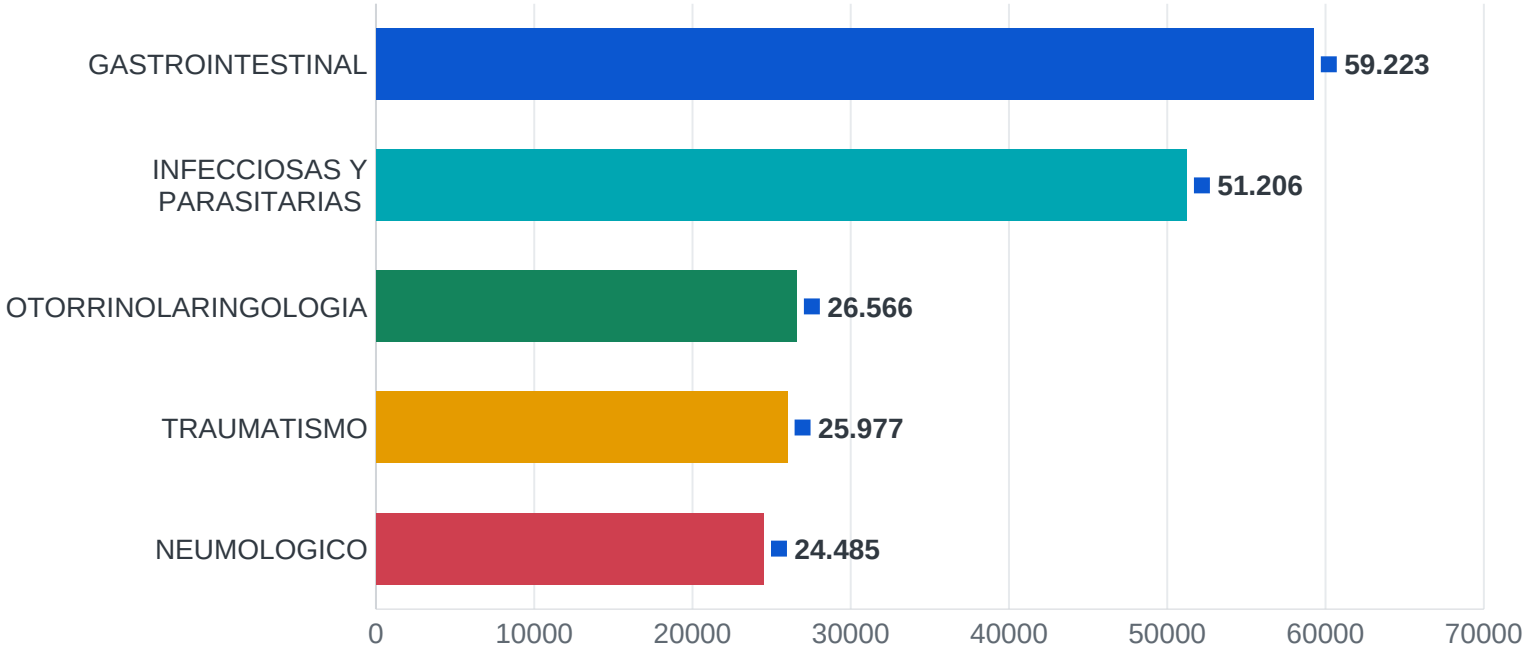
Medir eficiencia con producción, costo unitario, pertinencia y trazabilidad por servicio.

Fuente: base de producción y anexos vigentes. Unidad: actividades registradas; no pacientes ni registros diagnósticos RIPS.

Perfil epidemiológico y episodios trazadores

RIPS principal/egreso: 371.987 registros diagnósticos en el conjunto del aplicativo

Grupos clínicos con mayor frecuencia (registros)



Clasificación por validar

"DIAGNOSTICO NO VALIDO": 71.450 registros (19,21% del principal/egreso). Se conserva la etiqueta original; se excluye de este ranking clínico.

Episodios: etiquetas de la base

EXAMEN MEDICO GENERAL: 48.039.
INFECCIONES OTROS VIRUS: 38.365.
Son registros agrupados; no episodios únicos acreditados.

Todos los diagnósticos

745.006

Registros de la base completa

Principal / egreso

371.987

Registros seleccionados

Usuarios RIPS distintos

68.318

Identificadores del conjunto

Fuente: rips-v22-data.js del aplicativo vigente; recálculo documentado en rips_verified.json. Denominador clínico: 371.987 registros.

Lectura técnico-científica

Condiciones sanitarias para cualquier modelo de operación

Acceso

Garantizar oportunidad y continuidad de servicios materno-infantiles, urgencias y apoyo diagnóstico.

Calidad

Mantener seguridad del paciente, pertinencia, trazabilidad y continuidad de las rutas.

Riesgo

Medir captación, control, referencia y seguimiento de los grupos clínicos trazadores.

Resolutividad

Medir remisiones, capacidad de respuesta y tiempos críticos para apoyar a la red.

Información

Usar RIPS/FEV como insumo clínico, financiero y de auditoría, con reglas de calidad explícitas.

Gobernabilidad

Conservar control institucional sobre datos, activos, continuidad y resultados.

Fuente: diagnóstico integral y evaluación de valor público de la consultoría. Recomendaciones de gestión.

Valor público sanitario y territorial

Acceso, continuidad, equidad, sostenibilidad y gobernabilidad

Dimensión	Aporte del CAIMI	Riesgo de no gestionar
Acceso	Punto territorial de atención	Barreras y desplazamiento
Continuidad	Nodo de urgencias y apoyo diagnóstico	Fragmentación de las rutas
Equidad	Servicios para la población usuaria	Desatención o congestión
Sostenibilidad	Costos visibles y gestionables	Deterioro financiero
Gobernabilidad	Control público de resultados	Pérdida de información y trazabilidad

El modelo seleccionado debe preservar acceso efectivo, continuidad asistencial y control institucional, y demostrar su sostenibilidad con información conciliada.

Fuente: evaluación de valor público sanitario y territorial del informe de consultoría.

Capacidad instalada y procesos críticos

Puntos de control para el modelo operativo

Frente	Riesgo	Control propuesto
Admisiones y registro	Datos incompletos o inconsistentes	Validación y diccionario de datos
RIPS / FEV	Rechazos, devoluciones o glosas	Validación previa y soporte documental
Costos	Asignación incompleta o no trazable	Absorción con inductores y conciliación
Equipos	Condición técnica o identidad sin resolver	Verificar operación, identidad y criticidad
Talento humano	Productividad no medida	Agenda–producción–ausentismo

Ubicación, identificación y funcionamiento son atributos distintos. Cada proceso necesita un indicador, responsable, fuente, fecha de corte y evidencia mensual.

Fuentes: diagnóstico operativo, metodología institucional de costos y conciliación biomédica de esta actualización.

Equipos biomédicos: inventario consolidado

194 registros documentales; estados de fuentes con fechas diferentes

Estado documental	Registros
Operativo explícito	106
Operativo con observaciones	66
Fuera de servicio	5
Condición técnica por verificar	12
Intervención en proceso	1
Asociación descriptiva por corroborar	2
Sin reporte individual (8631)	1
Traslado a otra sede (IPC)	1
TOTAL	194

Regla de consolidación

Se actualizan 12 registros por placa o serie. Las 2 asociaciones descriptivas permanecen separadas hasta corroborar identidad.

Límite de interpretación

194 filas no acreditan 194 activos únicos. La serie 503352 figura en los ítems 85 y 88; no se elimina sin verificación.

No mide disponibilidad simultánea ni porcentaje operativo actual.

Fuentes: inventario institucional (194 filas) y certificación biomédica del 23-10-2026 con reportes de julio, agosto y octubre.

Certificación biomédica: alcance de la aclaración

Documento del 23 de octubre de 2026 · Kelly Catherine Reyes Moreno, ingeniera biomédica

Inicialmente no ubicados	Reportes individuales	Vínculos por clave	Asociaciones descriptivas
15	**14**	**12**	**2**
Hallazgo de la visita inicial	PDF: páginas 3 a 16	10 por placa + 2 por serie	Identidad por corroborar

Qué aclara la certificación

La no ubicación en la visita inicial pudo deberse a disponibilidad, acceso o ubicación en el servicio. Ese registro inicial no acredita por sí solo pérdida física.

Qué conserva como pendiente

Un registro —báscula de peso BADECOL, inventario 8631, serie 25689-334— no tiene reporte individual en el anexo recibido.

Nota de alcance: se incorpora evidencia documental posterior. Localizar o cerrar una orden de mantenimiento no equivale a acreditar funcionamiento, disponibilidad actual o recibo contractual.

Fuente: CERTIFICACIÓN EB CAIMI CON REPORTES.pdf, pp. 1–2 (certificación) y pp. 3–16 (14 reportes).

Equipos biomédicos: acciones individualizadas

Condición técnica consignada en los reportes; intervención propuesta con evidencia de cierre

Registro / equipo	Evidencia individual	Acción documentable
2820 · micropipeta	43823 · 08-10-2026 · p. 4 Fuera de servicio	Validar y tramitar recomendación de baja
3237 · equipo de órganos	42295 · 09-07-2026 · p. 5 Faltan dos cabezales	Restituir componentes y verificar operación
4427 · pesa bebé	40998 · 03-08-2026 · p. 8 Celda de pesaje dañada	Validar y tramitar recomendación de baja
3259 · succionador	43825 · 08-10-2026 · p. 7 Intervención en proceso	Instalar niple y cerrar con prueba funcional
3404 · succionador	43824 · 08-10-2026 · p. 3 Opera con observación	Sustituir recipiente fisurado y verificar
Fonendoscopio / lápiz halógeno	42238 / 42239 · 14-07-2026 · pp. 14–15	Corroborar identidad; atender baterías del lápiz
8631 · báscula BADECOL	Sin reporte individual	Solicitar soporte individual y condición técnica

Las recomendaciones de baja y reparación no se presentan como ejecutadas. El reporte del equipo 3237 concluye el servicio, pero describe una condición que impide declararlo operativo.

Fuente: reportes individuales de la certificación; referencia a páginas físicas del PDF recibido. Conciliación de los 15 registros en anexo.

Talento humano, ausentismo y productividad

Tablero mensual por perfil y servicio

Ausentismo	Permisos sindicales	Prioridad	Brecha
26	**9**	**Productividad**	**Homologación**
Registros en la base analizada	Registros; no días de ausencia	Por perfil y servicio	Agendas, personal y costos

- Homologar talento humano, agendas, producción y costos por profesional y servicio.
- Calcular días, horas, reemplazos y costo del ausentismo cuando existan soportes completos.
- Definir un tablero de productividad por servicio, perfil y modalidad de vinculación.

Las cifras describen registros de una base. Las decisiones de personal requieren medir productividad, oportunidad, carga asistencial y costos conciliados.

Fuente: base de ausentismo y diagnóstico de talento humano incorporados en los anexos vigentes.

Gobierno de datos y sistema de información

Condición habilitante para cualquier escenario

Eslabón	Control mínimo	Resultado esperado
RIPS	Reglas de validación y consistencia con FEV	Menor rechazo y mayor trazabilidad
Facturación	Soporte documental y control de tarifas	Radicación completa y verificable
Costos	Centro conciliado e inductores documentados	Costo unitario defendible
Recaudo	Pagador, vencimiento y atribución al CAIMI	Decisión financiera realista
Glosas	Auditoría por causal y valores monetarios	Separar frecuencia de impacto económico
Biomédica	Identificador, fecha, condición y evidencia	Trazabilidad de activos e intervención

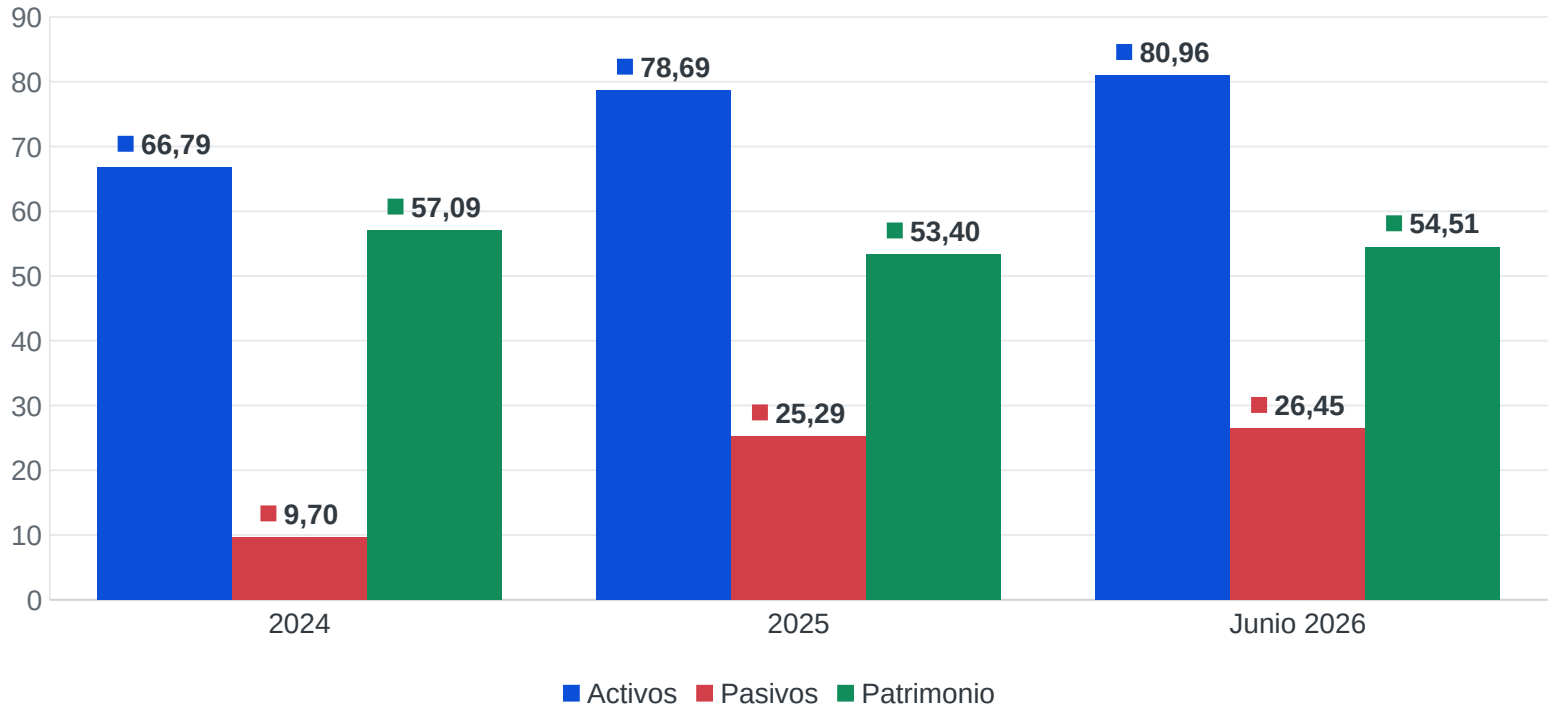
El sistema debe servir a clínica, facturación, costos, cartera, auditoría y supervisión. Cada tablero conservará su unidad y universo de observación.

Fuente: diagnóstico de información y controles de consistencia del paquete actualizado.

Contexto financiero institucional

Estados financieros de la E.S.E.; corte parcial a junio de 2026

E.S.E.: activos, pasivos y patrimonio (miles de millones COP)



Periodo	Resultado (mil MM COP)
2024	-0,22
2025	-3,69
Junio 2026	1,10

Junio de 2026

Periodo: +$1,10 mil MM.
Operación: –$1,55 mil MM.
Razón corriente: 1,21.

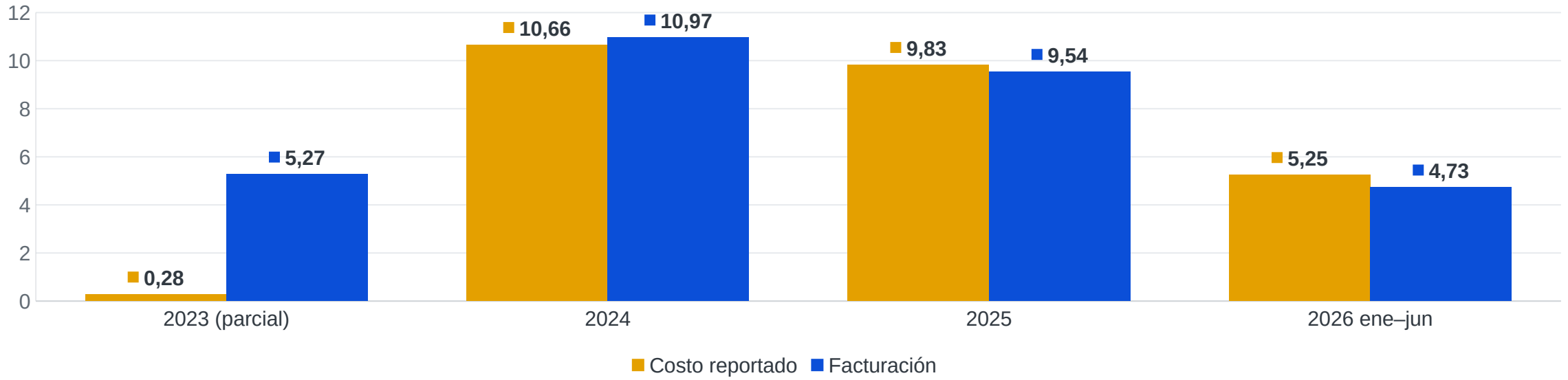
La presión de pasivos y el resultado institucional corresponden a toda la E.S.E.; no se atribuyen automáticamente al CAIMI. Junio de 2026 es un corte semestral.

Fuente: estados financieros E.S.E. a diciembre de 2024, diciembre de 2025 y junio de 2026; anexo financiero conciliado.

Costos reportados del CAIMI

Costeo por absorción y facturación: conservar corte, unidad y alcance

Costo reportado vs. facturación (miles de millones COP)



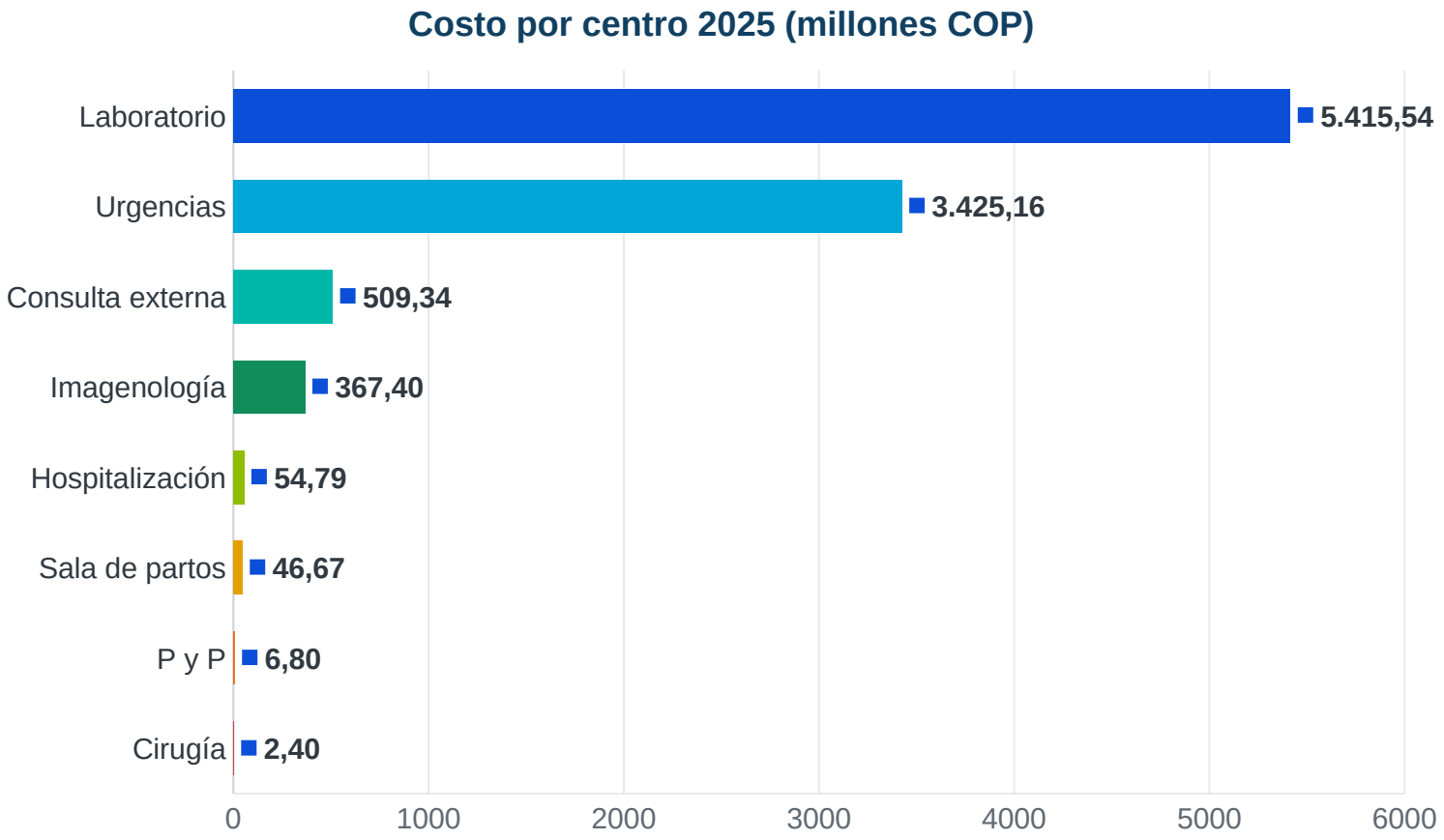
Periodo	Costo (millones COP)	Facturación (millones COP)	Facturación − costo
2023 parcial	280,82	5.274,63	4.993,81
2024	10.656,22	10.967,01	310,80
2025	9.828,12	9.535,47	-292,65
2026 ene–jun	5.250,30	4.730,20	-520,09

La diferencia no es utilidad neta ni flujo de caja. Conciliar recaudo, glosas monetarias, cartera e inversión; 2023 y 2026 son cortes parciales.

Fuente: 13_Costos_por_centro y 31_Conciliacion_Costos. 2026 incluye vigilancia epidemiológica: $11.822.187,89 COP.

Centros de costo

2025: ocho centros reportados; total $9.828,12 millones COP



Concentración del costo

Laboratorio y urgencias representan 89,95% del total reportado. Priorizar su conciliación con producción, facturación y recaudo.

Diferencia por aclarar · 2026

Urgencias-observación: total oficial menos suma de distribuciones = $246,42 millones. Se conserva el total oficial hasta aclaración de costos.

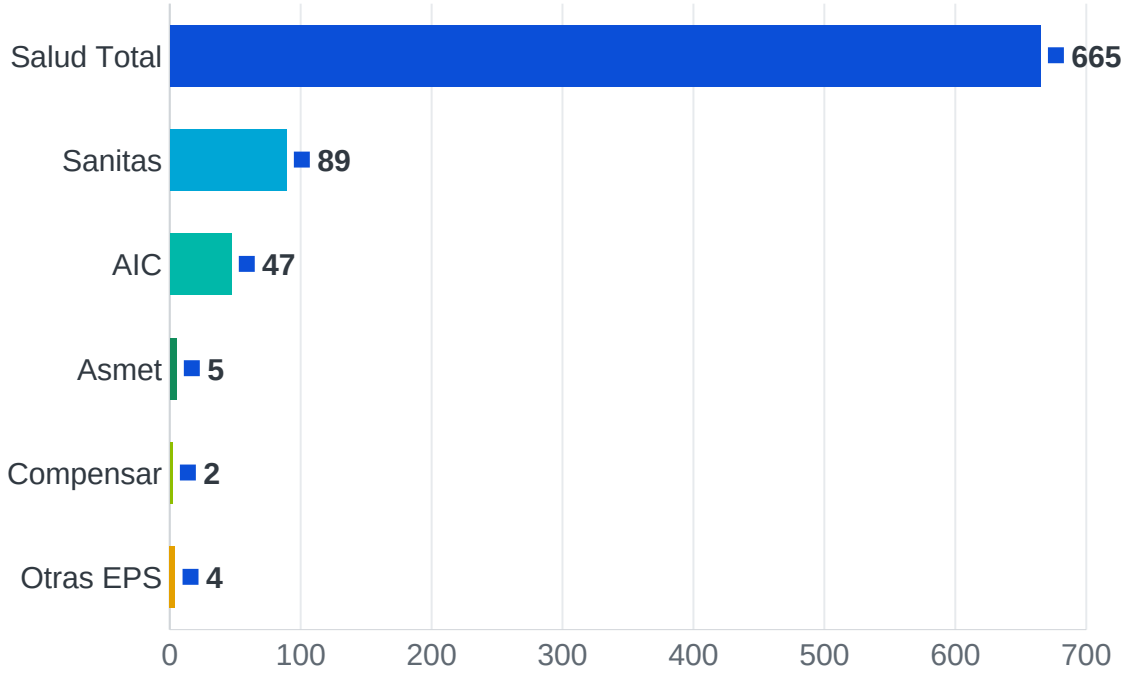
El gráfico usa valores de 2025. La discrepancia a la derecha corresponde exclusivamente a enero–junio de 2026.

Fuente: 13_Costos_por_centro. Discrepancia 2026: $1.908.717.995,43 − $1.662.296.225,81 = $246.421.769,62 COP.

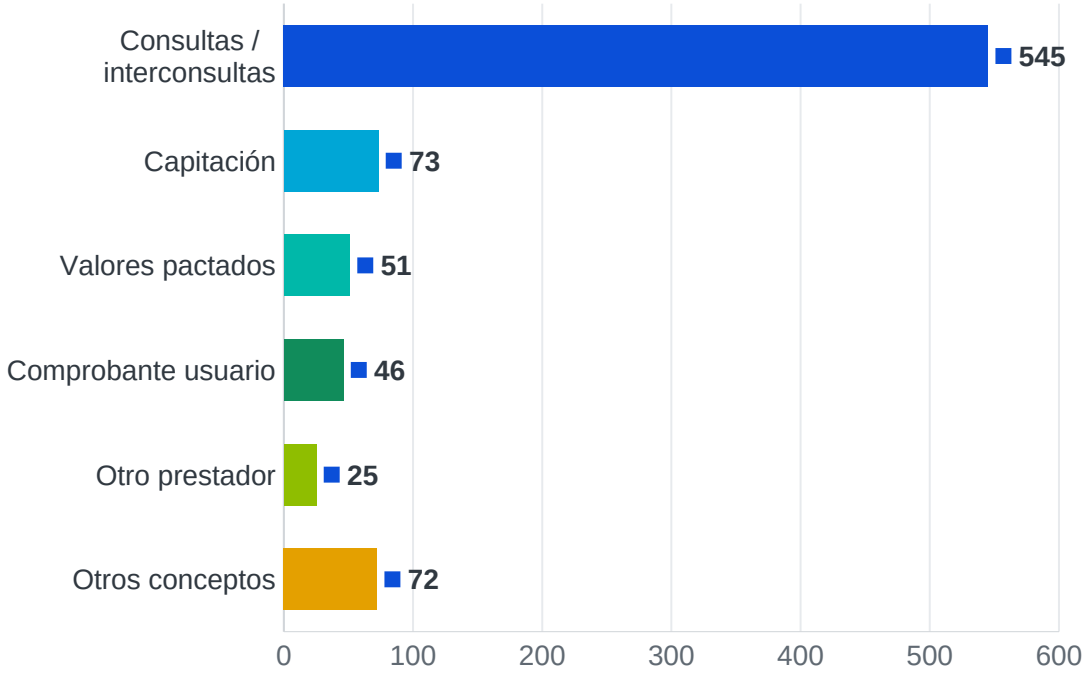
Facturación, RIPS, glosas y recaudo

812 registros de glosas: frecuencia de eventos, sin cuantía monetaria acreditada

Registros de glosa por EPS



Registros por concepto



Salud Total concentra 81,9% de los registros; consultas/interconsultas, 67,1%. Estas proporciones describen frecuencia y no participación del valor económico glosado.

Fuente: GLOSAS-1.xlsx y anexo de glosas vigente. No se interpreta la distribución por EPS como composición de usuarios RIPS.

Escenario 1 · Continuidad optimizada

Operación directa con metas verificables y control mensual

Puntaje uniforme

3,89 / 5

3,8875 exacto · ventaja mínima

Condición de éxito

Control mensual de productividad, costos, equipos, RIPS, glosas y conciliación financiera.

Interpretación

Mayor puntaje bajo pesos uniformes. La viabilidad financiera exige conciliación y un modelo económico.

Frente	Meta o control de gestión
Costos	Costo unitario mensual por centro
Facturación	Radicación completa y RIPS validados
Equipos	Meta propuesta: disponibilidad >95%
Talento humano	Productividad por perfil y servicio
Finanzas	Conciliación de costo, facturación y recaudo

La meta de disponibilidad >95% requiere fórmula, equipos elegibles, horas programadas y horas disponibles; no es un resultado medido por esta certificación.

Fuente: matriz de ocho criterios con peso técnico uniforme de 12,5%; metas propuestas para implementación.

Escenario 2 · Tercerización condicionada

Operación por desempeño, supervisión pública y reversibilidad

Puntaje uniforme

3,86 / 5

3,8625 exacto · recomendación condicionada

Potencial estratégico

Exigir desempeño, calidad y gestión de riesgos mediante reglas verificables. Los beneficios económicos deben demostrarse con el modelo conciliado.

Condición crítica

Rectoría, datos, activos y auditoría de la E.S.E., con retorno operativo.

Salvaguarda	Exigencia mínima
Información	Datos y RIPS/FEV disponibles y verificables
Calidad	Acceso, oportunidad y seguridad sin deterioro
Activos	Inventario individualizado y mantenimiento trazable
Glosas y recaudo	Metas y soporte de valores, sin inferirlos de conteos
Reversibilidad	Causales, recursos y plan de retorno operativo

La recomendación estratégica previa se mantiene condicionada. La comparación uniforme no ubica a tercerización en primer lugar ni prueba ahorro o rentabilidad.

Fuente: diagnóstico estratégico y matriz de ocho criterios, peso técnico uniforme de 12,5% por criterio.

Escenario 3 · Cierre o reconversión

El cierre simple no se recomienda con la evidencia disponible

Puntaje uniforme

2,50 / 5

2,5000 exacto · menor resultado

Riesgo crítico

Trasladar demanda sin red preparada puede afectar acceso, continuidad, oportunidad y confianza institucional.

Condición indispensable

Demostrar capacidad de absorción y continuidad en la red antes de una eventual reconversión.

- Documentar dónde y cómo se absorbería cada servicio y la demanda actual.
- Estimar costos de transición, traslado de equipos, personal, información y activos.
- Verificar acceso territorial, tiempos de respuesta y continuidad de las rutas.
- Definir seguimiento y contingencias antes de adoptar una decisión.

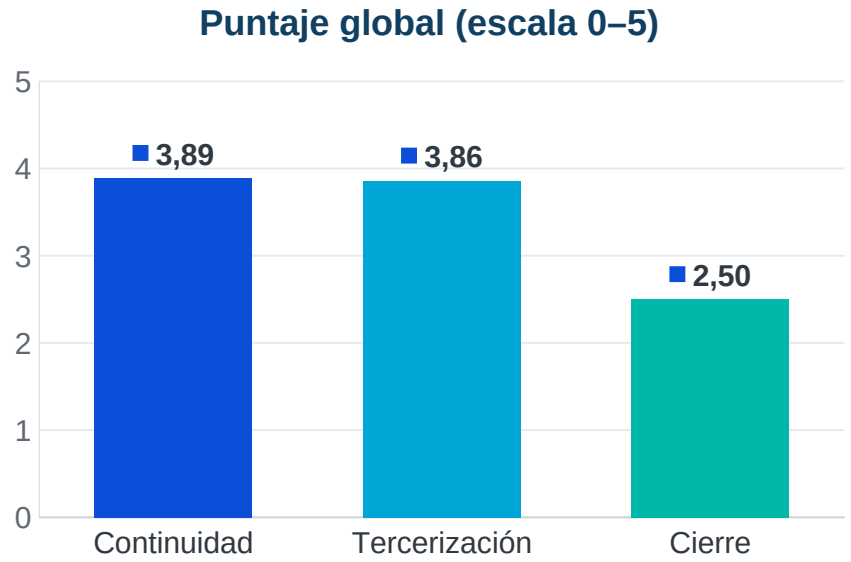
Fuente: evaluación de escenarios y matriz de ocho criterios con peso técnico uniforme de 12,5%.

Comparación multicriterio y sensibilidad

Ocho calificaciones originales; ponderación uniforme explícita de 12,5%

Criterio · peso 12,5%	Contin.	Tercer.	Cierre
Sanitario	4,2	4,0	2,2
Acceso	4,5	4,2	2,0
Calidad	3,7	4,1	2,8
Financiero	2,7	3,8	3,4
Operativo	3,2	4,1	2,8
Jurídico	4,0	3,5	2,6
Riesgo de implementación	4,5	3,2	2,3
Territorial	4,3	4,0	1,9
Promedio / 5	3,8875	3,8625	2,5000

Supuesto técnico para comparación, no ponderación aprobada. Mayor nota en riesgo de implementación significa mejor control o menor riesgo.



Sensibilidad

La ventaja de continuidad es 0,025 puntos. Cambios pequeños en pesos o calificaciones pueden modificar el orden; debe validarse el juicio institucional.

Fuente: ocho criterios y calificaciones de los anexos; promedio recalculado. No se alteran pesos para reproducir el ranking heredado.

Salvaguardas para la decisión

Condiciones de implementación y control institucional

Contrato por resultados

Indicadores, metas, niveles de servicio y consecuencias verificables.

Supervisión efectiva

Comité técnico, tablero mensual y actas con evidencia de seguimiento.

Datos y RIPS

Disponibilidad institucional, validación, soporte y trazabilidad del dato.

Activos y equipos

Inventario individualizado, condición técnica, mantenimiento y responsables.

Glosas y recaudo

Auditoría de la cuenta médica y conciliación de frecuencias y valores.

Reversibilidad

Plan financiado de retorno operativo ante incumplimientos críticos.

Fuente: recomendación estratégica y condiciones de implementación del informe de consultoría.

Riesgos críticos y mitigación

Controles que deben quedar en la implementación

Riesgo	Implicación	Mitigación prioritaria
Datos no conciliados	Modelo económico incompleto	Conciliar costos, facturación, recaudo y glosa monetaria
Clasificación RIPS no válida	Distorsión del perfil clínico	Validar etiqueta y reglas sin recodificación arbitraria
Identidad biomédica pendiente	Activos no individualizados	Corroborar 2 asociaciones, serie repetida y reporte 8631
Intervenciones técnicas abiertas	Continuidad o seguridad asistencial	Priorizar por criticidad y cerrar con prueba funcional
Tercerización con control débil	Pérdida de gobernabilidad	Contrato por indicadores, auditoría y reversibilidad
Cierre sin red preparada	Barreras y fragmentación	No ejecutar sin capacidad de absorción demostrada

Cada mitigación requiere responsable, fecha de compromiso y soporte. “No ubicado” en una visita no demuestra pérdida física ni autoriza borrar el registro.

Fuentes: matriz de riesgos, RIPS verificados, inventario biomédico y reportes de mantenimiento.

Hoja de ruta de implementación

Plazos propuestos desde la adopción institucional del plan

Horizonte propuesto	Objetivo	Productos verificables
0–30 días	Conciliar y priorizar	Conciliación financiera; individualización 8631 y asociaciones; priorización técnica
31–100 días	Diseñar y controlar	Tablero mensual; modelo económico; alternativa contractual o plan de continuidad
4–12 meses	Implementar	Modelo elegido con supervisión; mantenimiento, reposición y evidencia de resultados
13–24 meses	Evaluar	Impacto sanitario y financiero; continuidad, desempeño y reversibilidad

Secuencia propuesta: conciliar evidencia → diseñar el modelo → implementar con supervisión → evaluar resultados. Los plazos no modifican retroactivamente el contrato de consultoría.

Fuente: hoja de ruta del informe, actualizada con pendientes individualizados de la certificación biomédica.

Indicadores de seguimiento

Metas propuestas; cada fórmula requiere línea base y fuente

Indicador	Meta sugerida	Definición / evidencia mínima
Tasa monetaria de glosa	<3%	Valor glosado / valor facturado; cuantías aún por conciliar
RIPS validados	>98%	RIPS aceptados / RIPS generados en el periodo
Disponibilidad tecnológica	>95%	Horas disponibles / horas requeridas de equipos críticos
Costo por actividad	Reducción progresiva	Costo conciliado / actividades comparables por servicio
Cumplimiento de ruta	>90%	Atenciones RIAS cumplidas / atenciones programadas
Conciliación de datos	100% mensual	Centros conciliados / centros incluidos en el alcance

Estas cifras son metas de gestión, no resultados observados. La certificación no mide disponibilidad simultánea y los 812 registros no permiten calcular una tasa monetaria de glosa.

Fuente: tablero propuesto en el informe. Fórmulas y metas sujetas a validación institucional antes de su seguimiento.

Cierre ejecutivo

El CAIMI conserva valor público. La tercerización se mantiene como recomendación estratégica condicionada; la comparación uniforme favorece mínimamente a continuidad. La decisión requiere conciliación, salvaguardas y control institucional.

1. **Adoptar la hoja de ruta, sus responsables y el tablero mensual.**
2. **Corroborar pendientes biomédicos y formalizar salvaguardas.**
3. **Conservar control público de resultados, datos, activos y continuidad.**

La evidencia recibida se incorpora al cierre documental; su aprobación, liquidación y pago requieren las actuaciones correspondientes.

Carlos Alberto Sandoval Zambrano · Economista